Documento sin título

Universidad César Vallejo

Document Details

Submission ID

trn:oid:::27255:576396633

Submission Date

Apr 8, 2026, 11:53 PM GMT-5

Download Date

Apr 9, 2026, 12:02 AM GMT-5

File Name

Documento sin título

File Size

81.0 KB

26 Pages

11,846 Words

69,139 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

25% Internet sources
12% Publications
29% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

25% Internet sources
12% Publications
29% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	www.coursehero.com	3%
2	Internet	
	hdl.handle.net	1%
3	Internet	
	repositorio.ucv.edu.pe	<1%
4	Submitted works	
	Universidad Europea de Madrid on 2023-11-23	<1%
5	Submitted works	
	Universidad Nacional de Cajamarca on 2026-03-19	<1%
6	Submitted works	
	Universidad Nacional Federico Villarreal on 2026-01-30	<1%
7	Submitted works	
	ITESM: Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey on 2024-06-21	<1%
8	Internet	
	alicia.concytec.gob.pe	<1%
9	Submitted works	
	Universidad Cesar Vallejo on 2017-10-17	<1%
10	Submitted works	
	Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga on 2026-03-04	<1%
11	Internet	
	issuu.com	<1%

12 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2018-02-16 <1%

13 Internet

repositorio.unjfsc.edu.pe <1%

14 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-10-28 <1%

15 Internet

difuciencia.unibe.edu.py <1%

16 Internet

www.slideshare.net <1%

17 Internet

repositorio.uwiener.edu.pe <1%

18 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2024-07-31 <1%

19 Internet

worldwidescience.org <1%

20 Submitted works

Universidad Nacional de Cajamarca on 2026-03-14 <1%

21 Internet

prezi.com <1%

22 Internet

revistas.unilibre.edu.co <1%

23 Internet

www.icesi.edu.co <1%

24 Internet

repositorio.usm.cl <1%

25 Internet

revistas.unlp.edu.ar <1%

26 Publication

Aguilar Quispe, Wendy Lucero. "Clima organizacional y satisfacción laboral de los ... <1%

27 Submitted works

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga on 2026-03-04 <1%

28 Internet

es.scribd.com <1%

29 Submitted works

Universidad Nacional Federico Villarreal on 2025-12-03 <1%

30 Submitted works

Universidad Privada del Norte on 2025-09-26 <1%

31 Internet

omniscens.com <1%

32 Internet

repositorio.uladech.edu.pe <1%

33 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2024-08-08 <1%

34 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-07-24 <1%

35 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-12-26 <1%

36 Internet

repositorio.untumbes.edu.pe <1%

37 Submitted works

Universidad Autónoma de Ica on 2024-02-05 <1%

38 Submitted works

Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2025-10-20 <1%

39 Submitted works

Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC on 2026-03-29 <1%

40 Internet

backend.uniagustiniana.edu.co <1%

41 Submitted works

uncedu on 2024-11-22 <1%

42 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2018-01-07 <1%

43 Submitted works

POSGRADO on 2025-11-01 <1%

44 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2019-08-17 <1%

45 Submitted works

Universidad San Ignacio de Loyola on 2026-02-12 <1%

46 Submitted works

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion on 2025-11-14 <1%

47 Internet

dokumen.pub <1%

48 Internet

repositorio.usmp.edu.pe <1%

49 Publication

Florez Florez, Osmar Jose. "Eficiencia laboral y su relación con el régimen adminis... <1%

50 Submitted works

Universidad Nacional de Cajamarca on 2025-12-19 <1%

51 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-16 <1%

52 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-09-08 <1%

53 Submitted works

Universidad San Ignacio de Loyola on 2026-03-21 <1%

54 Internet

repositorio.uned.ac.cr <1%

55 Submitted works

Instituto Tecnologico de Costa Rica on 2023-10-04 <1%

56 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-21 <1%

57 Internet

repositorio-digital.cide.edu <1%

58 Submitted works

uffs on 2022-05-20 <1%

59 Submitted works

Integración ABbL on 2025-04-05 <1%

60 Submitted works

Universidad Anahuac México Sur on 2026-03-23 <1%

61 Internet

inba.info <1%

62 Submitted works

Universidad Nacional Federico Villarreal on 2025-11-12 <1%

63 Internet

www.diariodigital.com.do <1%

64 Submitted works

Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2024-06-16 <1%

65 Submitted works

Universidad Catolica Tecnologica de Barahona on 2025-11-17 <1%

66 Submitted works

Universidad Católica del CIBAO on 2023-11-22 <1%

67 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-22 <1%

68 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-12-19 <1%

69 Internet

ojs.southfloridapublishing.com <1%

70 Internet

www.minsalud.gov.co <1%

71 Submitted works

Foundation University, Islmabad on 2025-11-27 <1%

72 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-11-23 <1%

73 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-10-29 <1%

74 Internet

ardhindie.com <1%

75 Internet

instituciones.sld.cu <1%

76 Internet

www.game-learn.com <1%

77 Internet

1library.co <1%

78 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2024-07-24 <1%

79 Submitted works

Universidad Nacional Federico Villarreal on 2025-11-19 <1%

80 Internet

www.scilit.net <1%

81 Publication

Malimba, Danny Ronald Aguilar | Tejeda, Erick Eduardo Eguren | Torres, Jakson P... <1%

82 Publication

Martínez Chura, José. "La cultura organizacional y su incidencia a satisfacción lab... <1%

83 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2017-10-05 <1%

84 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2024-08-05 <1%

85 Submitted works

Universidad San Marcos on 2025-11-20 <1%

86 Submitted works

Universidad del Istmo de Panamá on 2026-02-04 <1%

87 Internet

repositorio.upch.edu.pe <1%

88 Internet

revista.nutricion.org <1%

89 Submitted works

uncedu on 2024-09-27 <1%

90 Internet

wma.comb.es <1%

91 Internet

www.publitec.com <1%

92 Submitted works

Aliat Universidades on 2025-10-26 <1%

93 Submitted works

Ana G. Méndez University on 2025-10-26 <1%

94 Publication

Gallegos Loayza, Jesus Efrain. "Interacción del liderazgo transformacional y el pa... <1%

95 Submitted works

Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2026-01-31 <1%

96 Submitted works

Universidad Andina del Cusco on 2026-03-16 <1%

97 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-07 <1%

98 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2018-11-29 <1%

99 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2024-08-09 <1%

100 Submitted works

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco on 2025-09-27 <1%

101 Submitted works

Universidad Ricardo Palma on 2024-03-15 <1%

102 Submitted works

Universidad Señor de Sipan on 2023-11-15 <1%

103 Submitted works

Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC on 2026-03-05 <1%

104 Internet

docplayer.es <1%

105 Internet

dspace.ueb.edu.ec <1%

106 Internet

export.thoth.pub <1%

107 Internet

hospicecare.com <1%

108 Internet

qa1.scielo.br <1%

109 Internet

repositorio.upec.edu.ec <1%

110 Internet

revistas.ucv.edu.pe <1%

111 Internet

tesla.puertomaderoeditorial.com.ar <1%

112 Internet

www.campusvirtualsp.org <1%

113 Internet

www.emagister.com <1%

114 Internet

www.ifac.org <1%

115 Internet

www.researchgate.net <1%

116 Publication

Bowden, Mathew. "An Analysis of the Subjective Socioeconomic Scale among His... <1%

117 Submitted works

Corporación Universitaria Minuto de Dios,UNIMINUTO on 2025-11-05 <1%

118 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-05-02 <1%

119 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-06-24 <1%

120 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-07-05 <1%

121 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-07-13 <1%

122 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2023-08-04 <1%

123 Submitted works

Universidad Privada San Juan Bautista on 2026-01-13 <1%

124 Submitted works

Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC on 2026-03-22 <1%

125 Submitted works

Universitat Internacional de Catalunya on 2026-02-20 <1%

126 Internet

bioetica.bioetica.org <1%

127 Internet

consultoria.grupoamh.com <1%

128 Internet

de.slideshare.net <1%

129 Internet

moam.info <1%

130 Submitted works

umb on 2024-06-24 <1%

131 Submitted works

usach on 2025-04-02 <1%

132 Internet

www.csic.edu.uy <1%

133 Internet

www.cytorex.com <1%

134 Internet

www.escuelaeuropeaexcelencia.com <1%

135 Internet

www.minsa-pmss.gob.ni <1%

136 Internet

www.risti.xyz <1%

137 Internet

www.vet.unne.edu.ar <1%

138 Internet

www.yumpu.com <1%

139 Publication

Moore, Maria-Anne. "Interculturality from Below: An Ethnography of Maternal He... <1%

140 Submitted works

National University College - Online on 2024-07-15 <1%

141 Submitted works

UNAPEC on 2024-11-07 <1%

142 Submitted works

Universidad Andina del Cusco on 2021-03-03 <1%

143 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-22 <1%

144 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-07-09 <1%

145 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-07-24 <1%

146 Submitted works

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala on 2026-03-25 <1%

147 Submitted works

Universidad Militar Nueva Granada on 2018-02-08 <1%

148 Submitted works

Universidad Nacional de Tumbes on 2025-08-15 <1%

149 Internet

es.slideshare.net <1%

150 Internet

repositorio.uas.edu.mx <1%

151 Internet

revistasojs.utn.edu.ec <1%

152 Submitted works

uncedu on 2024-01-25 <1%

153 Submitted works

uteg on 2025-06-13 <1%

154 Internet

www.americana.edu.py <1%

155 Internet

www.elargentino.com <1%

156 Internet

www.melillense.net <1%

157 Submitted works

Fundación Universitaria del Area Andina on 2023-08-17 <1%

158 Publication

Lajo Chevarría, José Fernando. "La gestión administrativa y satisfacción laboral d... <1%

159 Submitted works

Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2007-07-22 <1%

160 Submitted works

UNIV DE LAS AMERICAS on 2023-09-18 <1%

161 Submitted works

Universidad Abierta para Adultos on 2024-10-16 <1%

162 Submitted works

Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2025-09-21 <1%

163 Submitted works

Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2025-11-25 <1%

164 Submitted works

Universidad Autónoma de Ica on 2024-02-13 <1%

165 Submitted works

Universidad Católica San Pablo on 2026-03-26 <1%

166 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2016-06-22 <1%

167 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2024-07-15 <1%

168 Submitted works

Universidad Continental on 2022-03-08 <1%

169 Submitted works

Universidad Loyola Andalucia on 2021-11-11 <1%

170 Submitted works

Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzman y Valle on 2025-11-16 <1%

171 Submitted works

Universidad Nacional del Centro del Peru on 2025-05-28 <1%

172 Submitted works

Universidad de Guadalajara on 2022-07-13 <1%

173 Internet

anchor.fm <1%

174 Internet

busqueda.bvsalud.org <1%

175 Internet

docs.google.com <1%

176 Internet

dspace.uazuay.edu.ec <1%

177 Internet

es-us.noticias.yahoo.com <1%

178 Submitted works

lasallemx on 2025-12-12 <1%

179 Internet

mydata.iadb.org <1%

180 Internet
repositorio.udh.edu.pe <1%

181 Internet
repositorio.unc.edu.pe <1%

182 Internet
revistainstrumentacionquirurgica.unisinu.edu.co <1%

183 Internet
revistas.ujat.mx <1%

184 Internet
www.asesoriasparaeldesarrollo.cl <1%

185 Internet
www.gba.gob.ar <1%

186 Internet
www.proz.com <1%

187 Internet
www.redbogota.net <1%

188 Publication
Alanoca Gutierrez, Isabel. "Influencia del sistema de administración financiera SI... <1%

189 Submitted works
Ana G. Méndez University on 2025-09-26 <1%

190 Submitted works
Universidad Andina del Cusco on 2024-02-14 <1%

191 Submitted works
Universidad Católica de Santa María on 2015-08-28 <1%

192 Submitted works
Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-22 <1%

193 Submitted works
Universidad Cesar Vallejo on 2025-11-04 <1%

194 Submitted works

Universidad Privada del Norte on 2024-03-19 <1%

195 Submitted works

uncedu on 2025-02-03 <1%

196 Publication

Gavilano De La Cruz, Jesus Angel. "Nomofobia y rendimiento académico en integr... <1%

197 Submitted works

Uniminuto Virtual on 2026-04-05 <1%

198 Submitted works

Universidad Catolica De Cuenca on 2025-12-23 <1%

199 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2023-08-02 <1%

200 Submitted works

Universidad Cesar Vallejo on 2025-12-03 <1%

201 Submitted works

Universidad EAN on 2024-07-04 <1%

202 Submitted works

Universidad ESAN -- Escuela de Administración de Negocios para Graduados on 2... <1%

203 Submitted works

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga on 2023-11-17 <1%

204 Submitted works

Universidad Tecnologica del Peru on 2024-07-22 <1%

205 Submitted works

Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC on 2026-03-22 <1%

D. TÍTULO DE ANTEPROYECTO

"NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN UN HOSPITAL DE PIURA - PERÚ 2025"

E. RESPONSABLES

- Ejecutora

CD. Daiana Ailen Lozano Avila

- Asesora

Dra. Rosario Nelly Elera Ojeda

F. MARCO TEÓRICO

- Antecedentes de la investigación

Antecedentes locales

Santur L.1 (2024) desarrolló un trabajo de investigación orientado a analizar la influencia de la gestión de recursos humanos en la satisfacción laboral de los trabajadores de un establecimiento de salud de Piura. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de corte transversal y nivel correlacional, aplicándose cuestionarios a 41 colaboradores. En los resultados, se evidenció que el 45,2 % de los participantes percibió la gestión de recursos humanos en un nivel regular, mientras que el 38,7 % manifestó un nivel similar en su satisfacción laboral. Asimismo, se determinó una relación significativa entre ambas variables, destacando la motivación el factor de mayor influencia, seguida de la capacitación y la productividad.

Clavijo A.2 (2022) llevó a cabo una investigación orientada a determinar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en el personal administrativo en un hospital en Piura. El estudio correspondió a una investigación de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal, de nivel descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada por 86 trabajadores administrativos, a quienes se les aplicó el cuestionario. El análisis estadístico, realizado mediante el coeficiente de correlación de Spearmann, permitió identificar una relación positiva de magnitud media entre ambas variables.

Martínez L.3 (2021) realizó un estudio con el objetivo de evaluar la gestión administrativa en relación con la satisfacción del usuario en un

hospital de Piura. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo, no experimental y de corte transversal. Para la obtención de datos se aplicaron cuestionarios tanto al personal de salud como a los usuarios del servicio. Los resultados arrojaron una limitada relevancia entre la entidad y los colaboradores; además, aspectos como el liderazgo, toma de decisiones y el compromiso fueron valorados en niveles bajos por los usuarios. De igual manera, se identificaron niveles muy bajos en el cumplimiento de promesas, la eficiencia del servicio y la capacidad de respuesta. En términos generales, se concluyó que la gestión administrativa orientada a la satisfacción del usuario se encuentra en un nivel medio, sin embargo, la institución presenta potencial para optimizar sus recursos humanos y materiales.

Antecedentes Nacionales

Isuiza D., et al.4 (2023) desarrollaron una investigación orientada a explicar la satisfacción laboral del personal de salud en países como Perú, Bolivia y Brasil durante el contexto de la pandemia, considerando factores como motivación, las condiciones laborales y el burnout. El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de corte transversal, empleando instrumentos validados aplicados a 541 profesionales que laboraban en áreas críticas. Los hallazgos evidenciaron la existencia de una relación entre dichos factores y la satisfacción laboral, destacándose el 75,2% del personal se encontraba satisfecho laboralmente, el 57,7% presentó un nivel medio de burnout, el 20,5% se encontraba motivado y el 96,1% percibió adecuadas condiciones laborales. Se concluyó que, si bien estas variables explican parcialmente la satisfacción laboral, existen otros factores que también influyen en su comportamiento

Bustamante M., et al.5 (2022) realizaron un estudio con el objetivo de determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería en el sistema de salud público del Perú. La investigación fue de enfoque cuantitativo y alcance correlacional, aplicándose encuestas a 51 profesionales. Los resultados evidenciaron una relación positiva de intensidad moderada entre ambas variables, concluyéndose que el clima organizacional constituye un factor relevante en la satisfacción laboral del personal de enfermería.

Peñafiel F.6 (2022) llevó a cabo un estudio cuyo propósito fue analizar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en el personal sanitario de un hospital en Guayaquil. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y de nivel relacional. La muestra estuvo conformada por 50 trabajadores, a quienes se les aplicó una encuesta. Los resultados mostraron que no existe una relación estadísticamente significativa entre las variables; no obstante, se evidenció que el 68 % percibía la gestión administrativa como eficiente, mientras que el 84% del personal se consideraba regularmente satisfecho.

Acosta F.7 (2021) realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en profesionales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en Lima. El estudio fue de tipo descriptivo, analítico y correlacional, empleándose una muestra de 150 trabajadores a quienes se aplicaron instrumentos de medición para ambas variables. Los resultados evidenciaron la existencia de una relación positiva entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral, indicando que una adecuada gestión contribuye favorablemente al bienestar del personal de salud.

Riega G.8 (2020) desarrolló un estudio orientado a determinar la influencia de la gestión administrativa sanitaria en la implementación de un programa de mejora de la calidad en trabajadores del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en Lima. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, descriptivo-relacional. Se encuestó a 76 trabajadores, encontrándose que el 63,2 % percibía deficiencias en la comunicación interna, el 65,8 % consideraba inadecuada la planificación de actividades, el 64,5 % no aceptaba cambios organizacionales y el 56,6 % opinaba que las políticas públicas no eran adecuadas. En conclusión, se determinó que la gestión administrativa influye de manera significativa en la implementación de programas de mejora de la calidad institucional.

Antecedentes internacionales

Pérez Y., et al.9 (2023) realizaron un estudio con el objetivo de analizar el impacto de la pandemia por COVID-19 en la gestión administrativa de la Red de Salud Casanare ESE, así como generar evidencia para el diseño de lineamientos estratégicos. La investigación adoptó un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con diseño no experimental y alcance descriptivo. La muestra fue no probabilística por conveniencia, incluyendo a 6 trabajadores del área administrativa y 151 profesionales de salud. Como instrumento se empleó la escala SL-SPC compuesta por 27 ítems. Los resultados evidenciaron que la pandemia representó un desafío importante para la gestión clínica, obligando a la adaptación de protocolos e infraestructura. No obstante, se observó una adecuada capacidad de respuesta organizacional, lo que contribuyó positivamente en la satisfacción y bienestar de los usuarios internos.

Mariel S., et al.10 (2022) desarrollaron una investigación con el propósito de analizar la relación entre la sobrecarga laboral y la satisfacción del personal de enfermería en un hospital público de Buenos Aires, Argentina. El estudio fue de tipo descriptivo con corte transversal y contó con la participación de 97 profesionales de enfermería. Para la recolección de datos se utilizaron el Job Content Questionnaire y el Cuestionario Font-Roja. Los hallazgos indicaron que niveles más altos de formación académica se asocian con mayores niveles de estrés laboral. Asimismo, se evidenció que una mayor antigüedad laboral se relaciona con menor satisfacción; sin embargo, una mayor permanencia en la institución se vincula con niveles más altos de satisfacción laboral.

Venegas B, et al.11 (2022) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de identificar los niveles de motivación y satisfacción laboral del personal de enfermería en un establecimiento de salud de tercer nivel. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y corte transversal, con una muestra de 200 trabajadores. Los resultados evidenciaron que el 61% del personal presentó un nivel medio de motivación, mientras que el 56% mostró un nivel medio de satisfacción laboral. Estas condiciones estuvieron asociadas principalmente a factores como la limitada comunicación con los superiores, deficiencias en el trabajo en equipo y escaso reconocimiento laboral. Se concluye que la motivación constituye un elemento clave en el desempeño del personal de salud, especialmente en contextos de trabajo rutinario, donde la monotonía puede afectar el compromiso laboral.

Kachie y Lulin12 (2020) desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar la satisfacción laboral del personal de enfermería en hospitales de China, en el contexto de reformas del sistema de salud. La

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo y transversal, aplicándose el instrumento Index of Work Satisfaction a una muestra de 276 enfermeras. Los resultados evidenciaron que el nivel global de satisfacción laboral fue bajo (IWS = 10.179), destacándose mayor satisfacción en aspectos como la remuneración (12.126) y el estatus profesional (11.222), mientras que los niveles más bajos se presentaron en los requerimientos del trabajo (7.129) y las interacciones laborales (9.934). Asimismo, se identificó que las políticas organizacionales y la gestión institucional influyen en la percepción de satisfacción, evidenciando la importancia de la gestión administrativa en el bienestar del personal.

Ramos A, et al.13 (2020) desarrollaron un estudio orientado a evaluar la relación entre el bienestar psicológico y la satisfacción laboral en el personal administrativo de una institución de educación superior privada. La investigación fue de tipo no experimental, con diseño transversal y nivel correlacional, aplicándose a 147 trabajadores la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptada y la Escala de Satisfacción Laboral NTP 394. Los resultados evidenciaron la existencia de una relación significativa entre ambas variables, indicando que niveles más altos de bienestar psicológico se asocian con mayor satisfacción laboral.

Ángel E, et al.14 realizaron un estudio con el objetivo de analizar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en trabajadores de una institución de salud. La investigación fue de tipo cuantitativo, con diseño transversal y enfoque correlacional, con una muestra de 182 trabajadores. Los resultados evidenciaron que el 57% percibía el clima organizacional como susceptible de mejora, mientras que el 40,7 % manifestó niveles de satisfacción laboral. Asimismo, se identificó una relación significativa de intensidad moderada entre ambas variables.

Antecedentes locales

Autor /Año País /Región Variables Metodología Resultados principales Brecha identificada

Santur L.1 (2024) Piura – Perú Gestión de RR.HH. / Satisfacción laboral Cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional. Gestión de RR.HH. y satisfacción laboral en nivel regular; influencia significativa de la motivación. No evalúa gestión administrativa integral ni se centra en hospitales de mayor complejidad.

Clavijo A.2 (2022) Piura – Perú Gestión administrativa / Satisfacción laboral Cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional. Correlación positiva media entre ambas variables. Se limita al personal administrativo, no al personal de salud en general.

Martínez L.3 (2021) Piura – Perú Gestión administrativa / Satisfacción del usuario Cuantitativo, descriptivo, transversal. Gestión administrativa en nivel medio; bajo liderazgo y capacidad de respuesta. Analiza usuarios, no satisfacción del personal de salud.

Antecedentes nacionales

Autor /Año País Variables Metodología Resultados principales Brecha identificada

Isuiza D., et al.4 (2023) Latinoamérica (Perú, Bolivia y Brasil) Satisfacción laboral / Motivación / Condiciones laborales / Burnout Cuantitativo, no experimental, transversal, ex post facto. La satisfacción laboral del personal de salud se relaciona con la motivación, las condiciones laborales y el burnout. No incorpora la

gestión administrativa como variable de análisis que explique los niveles de satisfacción laboral.
Bustamante M., et al.5 (2022) Perú Clima organizacional / Satisfacción laboral Cuantitativo, correlacional. Existe relación positiva y moderada-alta entre clima organizacional y satisfacción laboral. Analiza el clima organizacional, pero no evalúa específicamente la gestión administrativa ni sus dimensiones.
Peñafiel F. 6 (2022) Ecuador Gestión administrativa / Satisfacción laboral Cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional. No se encontró relación significativa entre gestión administrativa y satisfacción laboral. Los resultados no profundizan en el nivel de satisfacción del personal ni analizan diferencias contextuales organizacionales.
Acosta F.7 (2021) Perú Gestión administrativa / Satisfacción laboral Cuantitativo, descriptivo-correlacional, no experimental. Existe relación positiva y moderada entre gestión administrativa y satisfacción laboral. Se centra en una institución específica, sin contrastar realidades organizacionales de otros contextos hospitalarios.

Riega G.8 (2020) Perú Gestión administrativa sanitaria / Programa de mejora de la calidad Cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional. La gestión administrativa sanitaria incide significativamente en la mejora de la calidad institucional. No analiza la satisfacción del personal de salud como variable dependiente.

Antecedentes internacionales
Autor /Año País Variables Metodología Resultados principales Brecha identificada
Pérez Y., et al.9 (2023) Colombia Gestión administrativa / Satisfacción del usuario interno Enfoque mixto, diseño no experimental, descriptivo-correlacional. Se evidenció asociación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción del usuario interno durante la pandemia por Covid-19; una adecuada planeación, organización, dirección y control se relacionan con mayor bienestar del usuario interno. Analiza satisfacción del usuario interno de forma general, sin diferenciar específicamente al personal de salud ni medir el nivel de satisfacción laboral como variable dependiente central.
Mariel S., et al.10 (2022) Argentina Sobrecarga laboral / Satisfacción laboral del personal de enfermería Enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, transversal. Se evidenció una relación significativa entre la sobrecarga laboral y la satisfacción laboral; a mayor carga laboral, menor nivel de satisfacción en el personal de enfermería.
Analiza factores laborales y psicosociales, pero no incorpora la gestión administrativa como variable explicativa de la satisfacción.
Venegas B., et al.11 (2022) Ecuador Motivación laboral / Satisfacción laboral del personal de enfermería Cuantitativo, descriptivo, transversal.
Se identificaron niveles medios de motivación y satisfacción laboral, asociados a reconocimiento, comunicación y liderazgo. Se centra

en motivación individual, sin evaluar de manera específica la gestión administrativa ni sus dimensiones.

Tetgoum, A. D., & Lulin, Z. (2020) China Satisfacción laboral del personal de enfermería / Componentes organizacionales (políticas, salario, interacción) Enfoque cuantitativo, diseño descriptivo transversal; muestra de 276 enfermeras; uso del Index of Work Satisfaction (IWS) Se evidenció un bajo nivel de satisfacción laboral global. Asimismo, las políticas organizacionales y condiciones institucionales influyen en la satisfacción, evidenciando el rol de la gestión administrativa.

Analiza la satisfacción laboral en personal de enfermería, pero no aborda directamente la relación específica entre satisfacción laboral y gestión administrativa como variable principal.

Ramos A., et al.13 (2020) Colombia Bienestar psicológico / Satisfacción laboral en personal administrativo Cuantitativo, correlacional, diseño transversal. Se encontró relación significativa entre bienestar psicológico y satisfacción laboral en personal administrativo. Analiza personal administrativo del sector educativo, no personal de salud ni la gestión administrativa hospitalaria.

Ángel E., et al.14 (2020) México Clima organizacional / Satisfacción laboral en trabajadores de la salud Cuantitativo, transversal, correlacional. Se evidenció relación significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral en trabajadores de la salud.

Evalúa el clima organizacional como predictor, pero no aborda directamente la gestión administrativa como variable central.

- Bases teóricas

Gestión administrativa

La administración científica emergió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, impulsado por la necesidad de optimizar los procesos de producción en las organizaciones. Autores como Adam Smith sentaron las bases con la idea de la división del trabajo, mientras que Frederick Winslow Taylor la llevó a un nuevo nivel con estudio de "tiempos y movimientos" que suponía analizar las tareas en detalle para identificar y eliminar movimientos innecesarios, optimizando así el tiempo y los recursos15.

Taylor y sus seguidores, entre ellos los esposos Gilbreth y Henry Gantt, se enfocaron en la eficiencia a través de la asignación específica de funciones y la estandarización de tareas, en este contexto se desarrolló la "Gráfica de Gantt", un instrumento de representación visual que permite estructurar la planificación y facilitar el control del avance de los proyectos. Henry Ford aplicó estos principios de manera radical con la línea de montaje, logrando una producción en masa sin precedentes15.

Max Weber, por su parte, desarrolló el concepto de burocracia, enfatizando la importancia de la estructura formal y la jerarquía para garantizar la coordinación de tareas y recursos15.

Henry Fayol sintetizó y amplió las ideas de sus predecesores, proponiendo cuatro funciones administrativas (planificación, organización, dirección y control) y catorce principios universales, entre los que destaca la división del trabajo, la autoridad, la disciplina y la unidad de mando. Las bases de este autor hoy sirven como guía para la gestión empresarial, aunque algunos de los principios se han adaptado a los nuevos contextos organizacionales15.

En la revisión teórica del término "gestión administrativa" se proponen múltiples definiciones conceptuales.
Mendoza y Moreira16 exponen que la gestión administrativa se define como el conjunto de actividades que se llevan a cabo de manera ordenada y consecutiva en las organizaciones. Estas actividades, planificadas, organizadas, controladas y dirigidas por los altos funcionarios, tienen la responsabilidad de conducir la empresa hacia el éxito.
Por otra parte, Chicaiza17 sustenta que la gestión administrativa consiste en tomar decisiones necesarias para que una organización alcance sus objetivos y mantenga coherencia con su misión institucional. Este proceso implica la aplicación de estrategias, el uso de conocimientos, el desarrollo de técnicas y la adecuada gestión de recursos, con el fin de afrontar y superar las dificultades que puedan presentarse en el cumplimiento de las metas establecidas.
Es importante destacar que este proceso tiene como fin principal alcanzar un propósito, el mismo que se logra implementando un plan de acción orientado al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en condiciones ideales de eficacia y eficiencia17.
La gestión administrativa, vista de una manera holística, se entiende como un proceso realizado por el consejo de administración y los demás miembros de una entidad, con capacidades que sugieren un grado razonable de seguridad18.
La gestión administrativa es, además, un conjunto de acciones mediante las cuales el gerente lleva a cabo sus actividades, cumpliendo con las fases del proceso administrativo, con el único objetivo de alcanzar las metas propuestas en la empresa19.
Existen procesos administrativos que constituyen fases sucesivas que abarcan la administración y se detallan a continuación; la previsión a su vez tiene etapas; objetivos e investigación; la primera se refiere a la fijación de metas mientras que la segunda se basa en hallar técnicas enfocadas en el cumplimiento de objetivos. Los principios de esta fase son; previsibilidad que proporciona orientación sobre la validez de las previsiones realizadas para ejecutarlas con la mayor confiabilidad posible; la objetividad, las previsiones deben sustentarse en hechos y no en opiniones; y el tercer principio, es la medición; las previsiones son de fiar si son medibles cualitativamente y cuantitativamente20.
La planificación, es un proceso que establece una relación entre la situación actual y un futuro deseado. Implica determinar misiones, objetivos y metas, así como idear estrategias, medios y recursos necesarios para alcanzarlos en un tiempo específico. Esta etapa es la base del proceso porque permite decidir de antemano qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y quienes deben realizar las actividades para garantizar la obtención de objetivos planteados en la empresa21.
En la actualidad esta fase es muy importante, pues aumenta la probabilidad de éxito en la ejecución de las actividades, sin planeamiento no se puede esperar ni eficacia ni eficiencia y mucho menos mantener el control operativo empresarial22.
La fase de organización se refiere a la función que tiene como objetivo definir y ordenar las actividades indispensables para lograr los objetivos organizacionales, dichas actividades son asignadas de acuerdo a los recursos disponibles teniendo en cuenta sus funciones acordes al puesto laboral, asimismo, se establece las relaciones de autoridad y la integración de los miembros del equipo23.

La dirección, por su parte, implica básicamente mandar, influenciar y motivar a los empleados para que realicen tareas fundamentales, esta fase es llevada a cabo por el jefe quien busca la obtención de los mejores resultados posibles por parte de cada componente de su unidad. Es aquí donde el tiempo en el puesto de gerencia y sus relaciones interpersonales con sus colaboradores juegan un papel importante, pues bajo el puesto de jefe debe dirigir tratando de persuadir a los trabajadores que se unan para lograr el futuro deseado24.

Con el propósito de garantizar que todas las actividades planificadas se ajusten a los objetivos de la organización, es que se realiza el control, en esta fase del proceso se evalúa y se corrige el desempeño tanto individual como organizacional. Implica comparar el desempeño con las metas propuestas, identificar desviaciones y corregirlas. Esto, facilita el cumplimiento de los planes y guía a los gerentes en el direccionamiento adecuado de recursos según meta especifica. Es decir, representa una fase del proceso administrativo que integra las actividades necesarias para comprobar que las operaciones realizadas coincidan con lo establecido en la planificación25.

Modelos de gestión de organizaciones de salud

Mejorar la eficiencia operativa, la calidad de los servicios y la satisfacción tanto del personal de salud como de los pacientes, dependen de la aplicación de los modelos de gestión administrativa. Estos modelos responden a prioridades según necesidades de cada establecimiento de salud, ya que no son las mismas en un hospital de alta complejidad a las de otro de baja complejidad26.

Modelo de gestión por procesos

Es una metodología que reorganiza los flujos de trabajo para generar mayor valor en los servicios de salud, a diferencia del clásico modelo tradicional burocrático, este modelo se enfoca en las expectativas y necesidades del usuario. Facilita la estandarización de las intervenciones del equipo clínico, adaptándose al entorno y recursos disponibles, y asegura eficiencia, efectividad y calidad en la atención26.

La gestión por procesos transforma las estructuras hospitalarias tradicionales; caracterizadas por su organización jerárquica vertical; hacia un modelo de coordinación transversal. Este enfoque promueve el reemplazo del desempeño individual por dinámicas colaborativas entre equipos de diferentes especialidades. Como resultado se optimiza la calidad de la atención gracias a la sinergia de saberes especializados, generando un valor añadido tanto para los pacientes como para la institución en conjunto26.

Modelo de gestión integrada

Frente a posibles eventualidades que representen una emergencia sanitaria, se hace imperativo modificar el modelo de salud, tal como sugiere pasar de un modelo curativo a uno predictivo. Esto exige que los profesionales desarrollen competencias de gestión y administración, permitiendo una respuesta oportuna y costo – efectiva frente a las necesidades de la población. Este es un modelo con carácter sistémico que articula las dimensiones clínicas, administrativas y preventivas del cuidado sanitario, orientado a la eficiencia en el uso de recursos y a la anticipación de riesgos en salud27.

Este modelo de gestión prioriza el abordaje integral de la salud, incorporando intervenciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, articuladas de forma

coordinada entre los distintos establecimientos sanitarios y los servicios de apoyo que conforman el sistema; todas estas acciones se materializan a partir de políticas, proyectos, estrategias y servicios; para garantizar el derecho a la salud27.

La aplicación de este modelo se fundamenta en la Atención Primaria en Salud (APS) con un manejo integral de la persona, la familia y la comunidad, durante el curso de su vida27.

Modelo de gestión participativa

Es un enfoque organizacional que se caracteriza por la conformación de equipos multidisciplinarios, la reducción de estructuras jerárquicas rígidas y la corresponsabilidad en la toma de decisiones clínicas y administrativas. Este modelo busca optimizar la gestión hospitalaria mediante la distribución equitativa del poder organizacional, incentivando la participación de los profesionales de la salud en procesos orientados a la mejora en la atención. Sin embargo; su efectividad se puede ver limitada si no se asegura un compromiso en equipo que respalde la descentralización de funciones, el fortalecimiento de los canales de comunicación y la alineación con las expectativas de los grupos involucrados28.

Gobernanza clínica

La gobernanza clínica se entiende como un marco organizacional orientado a garantizar la calidad, la seguridad y la mejora continua de la atención en los servicios de salud, mediante la integración de responsabilidades clínicas, gerenciales y de liderazgo institucional. Este enfoque parte del reconocimiento de que los resultados asistenciales no dependen exclusivamente del desempeño individual de los profesionales, sino de la existencia de estructuras organizativas, procesos definidos y mecanismos de rendición de cuentas que orienten la práctica clínica hacia estándares de calidad y seguridad29.

Desde una visión sistémica, la gobernanza clínica se inscribe dentro de la gobernanza de los servicios de salud, al articular los objetivos estratégicos institucionales con la gestión operativa y la práctica clínica cotidiana30. En coherencia con lo expuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los sistemas de salud con marcos de gobernanza sólidos presentan mayor capacidad para asegurar calidad asistencial, uso eficiente de recursos y mejora continua, especialmente cuando se apoyan en procesos de evaluación del desempeño, aprendizaje organizacional y toma de decisiones basada en evidencia31.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refuerza esta visión al destacar que la gobernanza efectiva constituye un pilar para el fortalecimiento de las redes integradas de servicios de salud, al promover coordinación, liderazgo institucional y orientación a resultados sanitarios. En sus desarrollos recientes, la OPS subraya que la calidad de la atención y la seguridad del paciente requieren estructuras de gobernanza que aseguren coherencia entre los niveles de gestión, los equipos clínicos y las políticas públicas, evitando la fragmentación de los servicios y favoreciendo la continuidad del cuidado32.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) incorpora de manera implícita principios alineados con la gobernanza clínica al enfatizar el fortalecimiento de la rectoría, la gestión institucional y la rendición de cuentas como componentes esenciales para mejorar el desempeño del sistema de salud. En ese sentido, los documentos de gestión institucional del MINSA resaltan la necesidad de la evaluación de resultados, el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano y la

consolidación de procesos organizativos orientados a la calidad y seguridad de la atención, lo que se vincula directamente con los fundamentos de la gobernanza clínica en contextos hospitalarios33.
La literatura científica reciente coincide en que uno de los fundamentos centrales de la gobernanza clínica es su orientación a la calidad asistencial como responsabilidad institucional y no solo profesional34.
Estudios empíricos muestran que la existencia de marcos de gobernanza clínica favorece la implementación consistente de guías clínicas, la reducción de la variabilidad injustificada de la atención y el fortalecimiento de una cultura organizacional orientada a la seguridad del paciente35. Asimismo, se ha evidenciado que los modelos de gobernanza clínica influyen positivamente en el clima laboral y en la capacidad de los equipos de salud para sostener procesos de mejora continua36.
En conjunto, estos elementos permiten conceptualizar la gobernanza clínica como un componente clave de la gestión de los servicios de salud, sustentado en principios de liderazgo, responsabilidad institucional, evaluación del desempeño y orientación a la calidad, coherente con los lineamientos internacionales de la OMS y la OPS, y con las políticas de fortalecimiento de la gobernanza sanitaria impulsadas por el MINSA.
Enfoques de gobernanza clínica
Se identifican distintos enfoques de gobernanza clínica que orientan la manera en que las organizaciones sanitarias conducen la práctica clínica y aseguran la calidad de la atención. Estos enfoques no constituyen modelos estandarizados, sino formas predominantes de organizar la toma de decisiones clínicas dentro de marcos institucionales específicos, en función del contexto organizativo y del rol que asumen los distintos niveles de gestión29,30.
Un primer enfoque corresponde a la gobernanza clínica institucional o centralizada, en la cual la conducción de la práctica clínica se encuentra fuertemente alineada a directrices, normas y mecanismos de control definidos a nivel institucional. En este enfoque, la organización cumple un rol rector en la regulación de la práctica clínica, priorizando la estandarización de procesos, la coherencia normativa y la supervisión del desempeño asistencial. Este tipo de gobernanza es frecuente en sistemas públicos y en contextos donde se busca fortalecer la capacidad de conducción institucional y reducir la variabilidad de la atención31,32,33.
Un segundo enfoque es la gobernanza clínica distribuida o descentralizada, que reconoce una mayor autonomía de los servicios y equipos clínicos en la toma de decisiones, dentro de un marco organizacional común. En este caso, la gobernanza se ejerce a través de mecanismos de coordinación, liderazgo compartido y participación profesional, favoreciendo la adaptación de la práctica clínica a las necesidades locales. Este enfoque se asocia con una mayor implicación del personal de salud y con entornos organizacionales orientados al aprendizaje y la mejora continua34,35,36.
Finalmente, se identifica un enfoque de gobernanza clínica orientada a la calidad y la mejora continua, en el cual la conducción clínica se articula mediante sistemas de evaluación del desempeño, retroalimentación y uso de información para la toma de decisiones. En este enfoque, la gobernanza clínica se expresa menos a través del control normativo y más mediante procesos sistemáticos que promueven la seguridad del paciente, la consistencia de la práctica clínica y el fortalecimiento de la capacidad institucional para sostener mejoras en el tiempo34,36,37.

Gestión por resultados en salud

La gestión por resultados en el sector salud se concibe como un enfoque de gestión pública que orienta la acción institucional hacia el logro de resultados sanitarios verificables, más que al simple cumplimiento de procedimientos administrativos. En este marco, la atención se desplaza hacia el desempeño de las organizaciones y el impacto efectivo de sus intervenciones sobre la salud de la población, lo que permite vincular la planificación institucional con objetivos sanitarios concretos38,39.

A nivel organizacional, la gestión por resultados supone la definición explícita de metas y el uso sistemático de información para evaluar el desempeño institucional. Este enfoque facilita la toma de decisiones basada en evidencia y contribuye a fortalecer la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado, especialmente en contextos donde los servicios de salud enfrentan restricciones estructurales y alta demanda asistencial40.

En el ámbito sanitario, la gestión por resultados trasciende su carácter instrumental y se configura como un proceso de transformación institucional. Su implementación favorece una cultura organizacional orientada a la responsabilidad por el desempeño y a la mejora sostenida de los servicios, permitiendo identificar brechas en la prestación, optimizar el uso de recursos y orientar la acción pública hacia resultados que generen valor en términos de salud41.

Indicadores de desempeño institucional en salud

Los indicadores de desempeño institucional en salud constituyen herramientas esenciales para el monitoreo sistemático del funcionamiento de los servicios sanitarios, facilitando la toma de decisiones informadas. Desde una perspectiva de gestión, estos indicadores permiten medir no solo resultados finales, sino también aspectos estructurales y de proceso que impactan directamente en la calidad y eficiencia de la atención. En este sentido, su uso se asocia a una visión integral del desempeño institucional, más allá del simple control administrativo42.

En el ámbito de los sistemas de salud, la literatura señala que los indicadores cumplen una función estratégica al facilitar el monitoreo continuo del cumplimiento de objetivos sanitarios y la evaluación del impacto de las políticas públicas. Su adecuada selección y análisis contribuyen a identificar brechas en el acceso, la cobertura y la continuidad de la atención, especialmente en el primer nivel de atención, donde se concentra la mayor parte de las necesidades de la población43.

Además, los indicadores de desempeño institucional permiten fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los servicios de salud. Al proporcionar información objetiva sobre el funcionamiento de las organizaciones sanitarias, estos instrumentos favorecen procesos de evaluación comparativa y respaldan la formulación de acciones de mejora orientadas a optimizar el desempeño global del sistema. Esta función resulta particularmente relevante en contextos de descentralización y gestión territorial de los servicios de salud44.

Así bien, la evidencia empírica muestra que el uso sistemático de indicadores de desempeño institucional se asocia con mejoras en la gestión del talento humano y en el clima organizacional, al permitir identificar factores críticos que afectan la eficiencia y sostenibilidad de los servicios. De este modo, los indicadores no solo cumplen una función evaluativa, sino que se convierten en insumos clave para la planificación estratégica y la mejora continua en las instituciones de salud45.

Calidad asistencial post-COVID-19

La pandemia por COVID-19 puso en evidencia las limitaciones estructurales y organizativas de los sistemas de salud para sostener niveles adecuados de calidad asistencial en contextos de alta presión sanitaria. Durante este periodo, se registraron disrupciones relevantes en la continuidad de la atención y en la oportunidad de los servicios, lo que impactó de manera negativa en la calidad global de la atención brindada. Estas afectaciones no se limitaron a la atención de pacientes con COVID-19, sino que también alcanzaron a otros grupos de usuarios, evidenciando la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante situaciones de crisis46.

En el escenario postpandemia, la calidad asistencial se asocia de manera directa con la capacidad de las organizaciones sanitarias para evaluar sistemáticamente su desempeño y orientar procesos de mejora continua. Los estudios analizados destacan la importancia de utilizar enfoques evaluativos que permitan identificar debilidades en la estructura y en los procesos de atención, con el fin de orientar decisiones organizacionales dirigidas a la recuperación de la calidad y a la sostenibilidad de los servicios en el tiempo. Este enfoque refuerza la idea de que la calidad asistencial post-COVID-19 constituye un proceso dinámico, vinculado a la gestión institucional y no solo a resultados puntuales47.

De igual modo, la evidencia empírica muestra que la reorganización de los servicios de salud desempeñó un papel clave en la preservación y recuperación de la calidad asistencial. La adaptación de los circuitos de atención, la priorización de servicios esenciales y la reorganización de la capacidad hospitalaria permitieron, en determinados contextos, mantener indicadores asistenciales estables e incluso mejorar algunos resultados clínicos. Estos hallazgos subrayan que la calidad post-COVID-19 depende en gran medida de la capacidad organizacional para ajustar sus procesos frente a escenarios cambiantes48.

La recuperación de la calidad asistencial en el periodo post-COVID-19 ha requerido restablecer la continuidad del cuidado y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud. La literatura revisada indica que los procesos de reorganización institucional orientados a fortalecer la continuidad asistencial constituyen un factor determinante para consolidar mejoras sostenidas en la calidad de la atención, especialmente en contextos de transición hacia nuevas formas de provisión de servicios49.

Políticas de mejora continua en salud

Las políticas de mejora continua en salud se conciben como marcos institucionales orientados a fortalecer de manera sostenida la calidad de los servicios sanitarios mediante procesos sistemáticos de evaluación y ajuste organizacional. Desde esta perspectiva, la mejora continua no se limita a intervenciones puntuales, sino que se integra como un componente permanente de la gestión de los servicios de salud, estrechamente vinculado a la planificación, el desempeño institucional y la rendición de cuentas50.

En el ámbito de la gestión sanitaria, la implementación de políticas de mejora continua requiere condiciones organizacionales que permitan su sostenibilidad en el tiempo, entre ellas marcos normativos claros, liderazgo institucional y mecanismos formales de coordinación que aseguren la alineación entre los objetivos estratégicos del sistema de

salud y las prácticas operativas de los servicios. Este enfoque favorece la coherencia entre gobernanza, gestión por resultados y mejora de la calidad51.

Las políticas de mejora continua se sustentan en el uso sistemático de información para orientar la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño institucional. La incorporación de indicadores de calidad, sistemas de monitoreo y procesos de evaluación permite identificar brechas en la prestación de los servicios y orientar acciones de mejora basadas en evidencia. En este sentido, la mejora continua se configura como un proceso dinámico de aprendizaje organizacional, que contribuye a fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante contextos cambiantes52.

De manera que, los enfoques contemporáneos de mejora continua en salud subrayan la importancia de una visión integral que articule distintos niveles del sistema y promueva una cultura organizacional orientada a la calidad. La institucionalización de estas políticas depende de la capacidad de los sistemas de salud para integrar la gobernanza, la gestión y la evaluación del desempeño en un marco coherente, capaz de generar mejoras sostenidas en la calidad de la atención53.

Habilidades gerenciales

Diversas investigaciones recientes en el ámbito de la organización coinciden en señalar que las instituciones exitosas son aquellas lideradas por individuos con altos niveles de competencia, formación especializada y calificados en habilidades gerenciales. Estas habilidades engloban un conjunto estructurado de conocimientos, destrezas y aptitudes que los administrativos ponen en práctica para ejecutar eficazmente diversas funciones organizacionales que conllevan a ciertos resultados54.

En el contexto de las instituciones de salud, los directivos se ven obligados a integrar ciertas habilidades para el ejercicio de sus funciones, de manera tal que afrontar los complejos escenarios en el sector sea un proceso llevado a cabo con decisión asertiva. Entonces podemos afirmar que el éxito de la organización de salud está directamente relacionado a las habilidades que el gerente ponga en marcha para la administración de su unidad54.

Liderazgo

Esta habilidad se define como el conjunto de conductas estratégicas y decisiones que el líder implementa con el propósito de inspirar, persuadir y movilizar el talento humano y a la organización hacia el logro de la visión. En el sector salud, esta habilidad adquiere una relevancia particular debido a la presencia de desafíos adaptativos, los cuales corresponden a problemas de naturaleza sistémica, poco estructurados y carentes de soluciones predefinidas55.

La resolución de dichos desafíos no reside en respuestas individuales, sino en la activación de la inteligencia colectiva presente en todos los niveles de la organización, comprometiendo tanto a las instituciones como a los diversos actores del sistema de salud. En este contexto, el liderazgo efectivo debe adoptar una perspectiva global, contemplar la totalidad del entorno organizacional, fomentar el compromiso del personal e impulsar formas de liderazgo emergente desde los niveles operativos55.

Comunicación efectiva

La comunicación, se concibe como una habilidad gerencial que vincula y define las relaciones organizacionales bajo el intercambio de ideas, la asignación de funciones y la construcción de compromisos. Esta habilidad necesita de empatía, pensamiento crítico y voluntad para escuchar de

manera activa a los demás, asimismo un gerente comunicativo será capaz de recibir, trasmitir y actuar en base a la información de la que dispone, además de demostrar organización cuando atienda las necesidades de información56.

La comunicación asertiva favorece el trabajo inter operacional y multidisciplinario, aspectos clave en la gestión en salud debido a la naturaleza multifactorial de las enfermedades, y se convierte en un factor determinante para el éxito del gerente56.

Adaptabilidad

Resulta una de las habilidades no solo deseables, sino necesarias para la gerencia administrativa en salud, pues es un sector cuyo entorno se caracteriza por cambios constantes, avances tecnológicos y desafíos organizacionales. Esta competencia permite no solo reaccionar a los cambios de manera oportuna, sino también anticiparse a ellos garantizando la sostenibilidad y la calidad en atención57.

Una muestra notable de los últimos tiempos fue la emergencia sanitaria vivida en el COVID-19, que demostró la imperiosa necesidad de la adaptabilidad de la gestión sanitaria para ajustarse proactivamente a nuevas circunstancias58.

Toma de decisiones

El dominio de esta competencia muestra una mayor aptitud para seleccionar alternativas informadas y alineadas con los objetivos institucionales. No obstante, esta habilidad acarrea la inherente asunción de riesgos que puede tener consecuencias positivas o negativas para la organización. Esta complejidad demanda que el encargado de la toma de decisiones posea una visión integral del contexto, junto con un pensamiento crítico y analítico que le permita ponderar adecuadamente las posibles adversidades. Es esta capacidad resolutiva la que diferencia a los gerentes efectivos, especialmente en organizaciones marcadas por la incertidumbre y la necesidad de respuestas rápidas, como lo es el sector de la salud59.

Satisfacción laboral

Este término es definido como un sentimiento de placer o desagrado que contrasta con los criterios de carácter objetivo. Este concepto permite a los directivos y gerentes de empresa comprender las reacciones de sus empleados frente a sus tareas y predecir el impacto de estas reacciones en su comportamiento futuro. Se refiere además de las actitudes de los trabajadores hacia su trabajo, las mismas que se basan en las creencias y valores que desarrollan respecto a su labor60.

La satisfacción laboral ha demostrado tanto teórica como empíricamente ser una variable crucial en las organizaciones que buscan alcanzar un desempeño superior. Para los responsables de la toma de decisiones, lograr la satisfacción laboral es un desafío continuo debido a la complejidad del recurso humano, pues, lo que resulta placentero para una persona puede no serlo para otra, esto complica la tarea de satisfacer a todos los empleados61.

De manera que, evaluar la satisfacción del personal en función de su entorno laboral constituye un aspecto clave para las organizaciones, ya que, se ha demostrado ser un factor fundamental en el rendimiento de los empleados. Eso, a su vez, influye en la satisfacción del cliente y en la calidad de los servicios ofrecidos, lo que permite alcanzar los objetivos organizacionales y obtener ventajas competitivas en el mercado62.

Tabla 1. Factores de satisfacción en el trabajo63

Factores de la satisfacción en el trabajo
Factores motivacionales Reconocimiento Se refiere a la valoración y apreciación del trabajo realizado por parte de los superiores.
Logros Se refiere a resultados positivos obtenidos por el trabajador como consecuencia del cumplimiento de sus objetivos.
Promoción Hace referencia a las oportunidades de ascenso dentro de la organización. Permite al trabajador percibir que su esfuerzo es valorado.
Trabajo en sí mismo Hace referencia a la naturaleza de las tareas que realiza el trabajador y al grado en que estas resultan interesantes, desafiantes y significativas, acordes a las capacidades del mismo.
Factores higiénicos Políticas y normas Se refiere a los lineamientos diseñados por la organización para regular el comportamiento laboral y proteger los intereses tanto institucionales como individuales.
Condiciones de trabajo Se refiere al entorno físico y organizacional en el que el trabajador desempeña sus funciones.
Salario Comprende la compensación económica que recibe el trabajador por el desempeño de sus funciones.
Supervisión Hace referencia al estilo de dirección y al nivel de apoyo brindado por los superiores.

La satisfacción laboral es fluctuante, ya que puede aumentar o disminuir según las expectativas que tiene el trabajador y las necesidades que se vayan satisfaciendo. Una de las teorías más significativas sobre este tema es la propuesta por Herzberg (1968) conocida como la teoría de los dos factores. Esta teoría identifica los factores de motivación, que contribuyen a incrementar la satisfacción del trabajador, y los factores de higiene, que, si están ausentes o son inadecuados, generan insatisfacción. No obstante, eliminar la insatisfacción laboral solo aborda unos de los aspectos planteados en la teoría de los dos factores. El segundo aspecto se logra al mejorar y fortalecer los elementos motivadores dentro de la organización, lo que no solo conduce a una mayor satisfacción laboral, sino también a un mejor rendimiento de los empleados. De manera que, es esencial eliminar la insatisfacción laboral antes de crear las condiciones para la satisfacción, ya que ambas son independientes y pueden interferir negativamente entre sí. La situación ideal en cualquier organización es aquella en la que se promueve una alta motivación en el personal, mientras que los factores de higiene se mantienen controlados63.
Según este modelo los factores de higiene o extrínsecos tienen función preventiva frente a la insatisfacción laboral, pero por sí solos no son suficientes para determinar la satisfacción. Esta última está determinada por factores motivacionales o intrínsecos, relacionados con las circunstancias del trabajo. Dicho de otro modo, la satisfacción laboral es generada únicamente por factores intrínsecos, mientras que la insatisfacción laboral es provocada por factores extrínsecos64,65. Logro, reconocimiento, progreso, trabajo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad, pertenecen a los factores motivadores y se centran en el contenido del trabajo; mientras que, políticas de la organización, calidad de supervisión, relaciones con los compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad en el empleo, condiciones de trabajo y posición social, son factores higiénicos que se relacionan con el contexto del trabajo66.

Por otro lado, tenemos la teoría que postula Lawler (1973) quien destaca la relación expectativa – recompensa, esta teoría sienta sus bases en una probabilidad subjetiva de ambas variables que rigen la motivación de un empleado para desempeñarse de forma efectiva. La primera probabilidad indica que dedicar una cierta cantidad de esfuerzo a realizar una tarea de manera efectiva se asocia a una recompensa o un resultado positivo. Esta probabilidad se determina por dos probabilidades subjetivas secundarias: la probabilidad que el esfuerzo puesto en la labor encomendada lleve a la eficiencia y la probabilidad de que la eficiencia sea merecedora de una recompensa. En otras palabras, la satisfacción depende de la recompensa que el empleado recibe por su rendimiento en el trabajo y de lo que él considera adecuado recibir. Si la recompensa es mayor de lo esperado, el individuo alcanza un nivel de satisfacción; caso contrario, se produce insatisfacción66.

Clayton Alderfer, por su parte, basándose en la revisión de los postulados de la teoría de Maslow, estableció su propia teoría denominada ERG – existencia, relación y crecimiento. De esta revisión resultó la agrupación de las necesidades humanas en las tres categorías mencionadas previamente67.

Existencia; engloba las necesidades más básicas, las cuales Maslow las considera como fisiológicas y de seguridad67.

Relación; estas necesidades, que incluyen la necesidad social y el componente externo de la estima según Maslow, requieren interacción con otras personas para su satisfacción67.

Crecimiento; esta necesidad está referida a las oportunidades que brinda la organización para el crecimiento de los empleados, representa el deseo de desarrollo personal interno, incluye el componente interno de la estima y auto realización según la clasificación de Maslow67.

Locke postuló su teoría de la fijación de metas, en el centro de esta teoría se encuentra la acción con intención. Las personas eligen metas que están vinculadas con la satisfacción de sus necesidades, y la aspiración y la búsqueda de estas metas son fundamentales en el proceso vital. La acción consciente y auto dirigida es el principal eje detrás de la mayoría de las conductas humanas, impulsando el proceso motivacional. Esta teoría nos dice también que, las metas concretas generan mayor motivación que las metas generales en relación al desempeño laboral, sin embargo, para que el establecimiento de metas sea eficaz, es necesario que los individuos cuenten con las competencias necesarias para realizar las tareas y estén comprometidos con el logro de dichas metas68.

La percepción que tienen los empleados respecto a la correspondencia entre los esfuerzos invertidos y las recompensas recibidas, es crucial para su satisfacción, compromiso y rendimiento en el trabajo. Uno de los modelos más destacados en este campo es la teoría de la equidad de John Stacey Adams, que se enfoca en cómo los empleados perciben la equidad entre los esfuerzos y recompensas, esta teoría ofrece una representación valiosa sobre cómo los individuos evalúan la justicia en el trabajo y cómo esto impacta en su actitud y comportamiento laboral69.

Esta teoría tiene implicaciones importantes en la gestión de recursos humanos, en la medida que se relaciona con los salarios y beneficios justos. En ese sentido, los gerentes deben asegurarse de compensar a sus colaboradores de manera justa y equitativa. Asimismo, es necesario establecer una comunicación abierta con respecto a las políticas de recompensa para reducir la percepción de injusticia; por otro lado, los procesos de evaluación del desempeño deben ser objetivos. Además, es

importante considerar las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional y, finalmente, los gerentes deben abordar los conflictos de manera efectiva para mantener un entorno laboral justo70,71.

- Definición de términos básicos

Nivel

Se refiere a una escala o rango que indica el grado o clasificación dentro de una categoría jerárquica72.

Satisfacción laboral

Término que engloba el conjunto de actitudes que una persona adopta frente a su situación de trabajo, las mismas que pueden estar influenciadas por aspectos generales como aspectos particulares73.

Gestión

Es el proceso de diseño y mantenimiento de un ambiente en que las personas, trabajando en equipo, alcanzan en forma efectiva los objetivos establecidos en la organización. Gestionar implica estructurar el proceso administrativo a través de la planeación estratégica74.

Procesos

Es una secuencia de pasos dispuesta de manera lógica que se enfoca en lograr un resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento diseñados para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún de problema75.

Optimización

Es la actividad de seleccionar, entre las posibles soluciones de un problema, la mejor, la cual se evalúa tras un criterio predefinido76.

Desempeño organizacional

Se refiere a la capacidad de la empresa para hacer frente a las condiciones cambiantes del mercado y alcanzar sus metas, se basa en la forma en que se llevan a cabo las actividades incluyendo la calidad, la eficiencia y la eficacia con la que se realizan, así bien, el buen desempeño organizacional se traduce en resultados superiores a los esperados en términos financieros, operativos y de gestión de talento77.

Rendimiento

Se refiere a los resultados cuantificables y tangibles obtenidos de una actividad, proceso o inversión, es la medida de la eficacia con la que se alcanzan las metas trazadas, expresada en términos de productividad y rentabilidad78.

Calidad

Se define por la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las expectativas y requerimientos del cliente, de modo que, es un concepto subjetivo, variante de persona a persona. Además, es todo aquello que incrementa el valor percibido por el cliente79.

Eficacia

La eficacia se refiere a la capacidad de un proceso para cumplir con los requisitos o expectativas establecidas, sin prestar atención a la cantidad de recursos utilizados80.

Eficiencia

La eficiencia se relaciona con la optimización de recursos para lograr la producción deseada, es decir, hacer más con menos, se enfoca en el uso apropiado de los recursos para alcanzar un objetivo específico81.

Sexo

El sexo biológico se refiere a la diferenciación natural determinada por la dotación cromosómica donde XX corresponde al sexo femenino y XY corresponde al sexo masculino82.

Edad

Intervalo temporal que ha vivido un individuo desde su nacimiento, se expresa generalmente en años83.

Servicios hospitalarios

Unidades funcionales que se integran en un hospital, con funciones y competencias propias que se distinguen entre sí, en la que el personal desempeña sus labores (ejemplo: emergencia, hospitalización, consultorios externos, administración, entre otros)84.

Modalidad de contrato

Es la relación laboral formal, amparada legalmente bajo la cual un trabajador presta sus servicios a su entidad empleadora bajo un régimen específico de contratación85.

Tiempo de servicio

Es el periodo durante el cual un trabajador desempeña sus funciones en su entidad empleadora, sustentado en la existencia de un vínculo laboral, cuyo reconocimiento y efectos dependen de dicha relación contractual86.

G. EL PROBLEMA

- Planteamiento del problema

La gestión administrativa en los sistemas de salud latinoamericanos enfrenta desafíos multifacéticos, entre los que destacan la escasez de recursos, el crecimiento poblacional, la diversidad de necesidades de salud y la fragmentación de los sistemas; factores que, combinados con la presión por brindar servicios de calidad en un contexto de limitados presupuestos, exigen una gestión administrativa altamente eficiente y adaptable87,88.

En este escenario, la calidad de la atención médica se encuentra estrechamente vinculada a la efectividad de la gestión administrativa, entendida como un proceso dinámico y complejo que implica no solo la optimización de los recursos, sino también la implementación de procesos ágiles y transparentes, la toma de decisiones basadas en evidencia y la promoción de una cultura organizacional orientada a la mejora continua. Asimismo, la incertidumbre inherente a los sistemas de salud, agravada por eventos como pandemias o desastres naturales, demanda una gestión proactiva con visión de largo plazo, capaz de anticipar riesgos, desarrollar planes de contingencia y garantizar la continuidad de los servicios89,90,91.

El personal de salud es el recurso humano más valioso de cualquier institución sanitaria. Su satisfacción laboral es un factor determinante de la calidad de la atención, ya que influye en su motivación, su compromiso y su capacidad para brindar cuidados integrales a los pacientes. Los factores que influyen en la satisfacción del personal son múltiples y complejos, e incluyen no solo las condiciones laborales y las oportunidades de desarrollo profesional, sino también la percepción de justicia organizacional, la relación con sus superiores y la oportunidad de participar en la toma de decisiones92.

Por otro lado, la satisfacción del paciente constituye un indicador clave de la calidad percibida de los servicios de salud, influenciada por factores como la oportunidad y eficiencia de la atención, la comunicación con el personal de salud, la accesibilidad a los servicios y la experiencia general del usuario93.

La gestión administrativa eficiente y la satisfacción del personal de salud son factores clave para la calidad y operatividad de los servicios sanitarios. Sin embargo, en la región Piura, se han identificado desafíos

persistentes en este ámbito, los cuales impactan directamente en el bienestar del personal y, por ende, la calidad de la atención del usuario. En este contexto, la problemática se acrecienta en hospitales de tercer nivel de complejidad, como lo es el Hospital de la Amistad Perú – Corea Santa Rosa, que cuenta con una dotación aproximada de más de 1000 trabajadores del área asistencial, concentra una elevada demanda asistencial y cumple funciones de referencia para establecimientos de menor capacidad resolutiva2,3.

Estudios locales han revelado que la gestión administrativa en los hospitales de Piura presenta un nivel promedio en aspectos relacionados a la satisfacción del usuario, pese que las instituciones poseen un considerable potencial para mejorar sus recursos físicos y humanos3. Se identificó que los estilos de liderazgo, la toma de decisiones y la evaluación de resultados se sitúan en niveles bajos. Asimismo, los procesos de planificación, organización, dirección y control – elementos fundamentales en la gestión administrativa – muestran deficiencias en su ejecución. Un ejemplo representativo de esta problemática se observa en el área de logística, donde una investigación realizada en el hospital Santa Rosa II – 2 de Piura evidenció que el 70,37% del personal no aplicaba la normativa vigente para la contratación de bienes y servicios, comprometiendo la transparencia y la eficiencia en la distribución de los recursos institucionales3.

De manera más específica, la situación en los hospitales de Piura es preocupante debido a la creciente demanda de atención, sumada a la percepción de una gestión administrativa inadecuada y a una comunicación deficiente entre funcionarios y colaboradores durante la fase de planificación, lo que causa descontento entre el personal. Un estudio realizado en el año 2022 en la región, reveló que en 57,3% de los encuestados evaluó la gestión administrativa como deficiente, mientras que un alarmante 69,3% manifestó insatisfacción laboral, resultados que evidencian una clara relación entre la gestión administrativa ineficiente y la baja satisfacción del personal de salud2.

Por otro lado, la gestión de recursos humanos en los establecimientos de salud de Piura también contribuye a esta problemática. En el año 2024, el 45,2% de los trabajadores de un centro de salud considero que la gestión de recursos humanos era "regular", y el 38,7% indicó que su nivel de satisfacción laboral se ubicaba en la misma categoría. Esta situación se refleja en la productividad, ya que el 58,1% de los encuestados la calificó como "mala" y el 29% relacionó este bajo desempeño con la insatisfacción laboral1.

Estas deficiencias en la gestión administrativa y la insatisfacción del personal de salud tienen consecuencias directas en la calidad de la atención al usuario. Se ha documentado la falta de atención oportuna, reflejada en quejas sobre la lentitud en la asignación de citas y la atención en general. En lo que respecta a la comunicación institucional, el 40% de los encuestados manifestó que esta es casi nula, poco fluida y carente de claridad. Sumado a ello, la baja disponibilidad del personal para brindar apoyo y la atención inoportuna en algunos casos sitúan estos aspectos en niveles muy bajos, con promedios por encima del 70% en la escala "casi nunca", lo que afecta la confianza de los usuarios y la credibilidad de los establecimientos de salud3.

Enmarcados en esta realidad, resulta necesario evaluar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa del hospital, a fin de reconocer áreas críticas y oportunidades de mejora que

contribuyan al fortalecimiento institucional, al bienestar del recurso humano y, de manera directa, a la mejora en la calidad de los servicios sanitarios ofrecidos a la población piurana.

- Formulación del problema

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025?

Problemas específicos

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa, en un hospital de Piura – Perú 2025, según el servicio en el que labora?

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa, en un hospital de Piura – Perú 2025, según la modalidad de contrato?

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa, en un hospital de Piura – Perú 2025, según tiempo de servicio?

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa, en un hospital de Piura – Perú 2025, según sexo?

- Justificación

La presente investigación es de gran relevancia para comprender el impacto de la gestión administrativa en el nivel de satisfacción del personal de salud, un aspecto critico en el desempeño organizacional de instituciones de salud públicas en el Perú. En el contexto actual, donde los sistemas de salud enfrentan desafíos constantes debido a la creciente demanda de servicios y la limitada disponibilidad de recursos, resulta fundamental evaluar la percepción del personal sanitario sobre los procesos administrativos que rigen su entorno laboral.

Desde una perspectiva teórica, este estudio contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en el sector salud, integrando conceptos clave de gestión organizacional y bienestar laboral. Además, fortalecerá el marco de referencia para futuras investigaciones en instituciones similares, facilitando la generación de estrategias basadas en evidencia científica para optimizar los procesos administrativos.

En el ámbito práctico, los resultados obtenidos serán útiles para identificar fortalezas y áreas de mejora en la gestión administrativa del hospital, permitiendo diseñar e implementar políticas que promuevan un ambiente laboral más satisfactorio para el personal. Esto impactará positivamente no solo en la calidad de vida de los trabajadores, sino también en la calidad del servicio brindado a los pacientes, al mejorar la motivación, el desempeño y la productividad del equipo de salud.

Así bien, desde un enfoque social, esta investigación busca contribuir al fortalecimiento del sistema de salud pública de Piura, promoviendo un entorno de trabajo más justo y eficiente. Al abordar de manera integral las necesidades del personal, se fomenta una cultura organizacional orientada al bienestar, la equidad y la excelencia, factores clave para garantizar el derecho a la salud de la población peruana.

- Alcances y limitaciones

Alcances

Esta investigación tiene como propósito principal evaluar el nivel de satisfacción del personal de salud en relación con la gestión administrativa en un hospital de Piura, en el año 2025. Este estudio se centra en analizar como los procesos de planeación, organización, dirección y control impactan en aspectos fundamentales de la satisfacción

laboral, como las condiciones físicas y materiales de trabajo, los beneficios laborales, las políticas administrativas, las relaciones sociales, el desempeño de tareas, el desarrollo personal y la relación con la autoridad. La elección de estas dimensiones busca proporcionar una visión integral sobre los factores que influyen en la percepción del personal de salud respecto a su entorno laboral y su desempeño.

La relevancia de este estudio radica en su contribución al diseño de estrategias orientadas a optimizar los procesos administrativos y fortalecer el bienestar del personal de salud. Una gestión administrativa eficiente no solo impacta directamente en la satisfacción del personal, sino también mejora la calidad los servicios brindados a los pacientes, promoviendo un sistema de salud más efectivo y equitativo. En ese sentido, los resultados de esta investigación podrán servir como referencia para la implementación de mejoras administrativas que respondan a las necesidades del personal y se traduzcan en un mejor desempeño organizacional.

Limitaciones

El desarrollo del estudio presenta algunas limitaciones. La participación del personal de salud podría verse afectada por su disponibilidad de tiempo debido a la carga laboral o a eventos imprevistos, como emergencias sanitarias. Estas circunstancias podrían influir en la percepción y disposición de los participantes para completar los instrumentos de recolección de datos. Además, aunque se utilizarán herramientas validadas, la subjetividad inherente en la interpretación de los ítems podría generar sesgos en los resultados. Asimismo, los hallazgos estarán circunscritos al contexto específico del hospital en estudio, lo que restringe su aplicabilidad directa a otras instituciones de salud. Pese a estas limitaciones, se tomarán las medidas necesarias para minimizar su impacto, asegurando validez y fiabilidad del análisis.

H. OBJETIVOS

- Objetivo general

Determinar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025.

- Objetivos específicos

Identificar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025, según servicio en el que labora.

Identificar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025, según modalidad de contrato.

Identificar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025, según tiempo de servicio.

Identificar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025, según sexo.

Identificar el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025, según edad.

I. HIPÓTESIS

- Hipótesis

Hi: El nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en el hospital es regular.

H0: El nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en el hospital no es regular.

- Variables - Operacionalización de la variable

Variable: Nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa

Variables intervinientes:

- Características personales (Edad, sexo)
- Características laborales (Servicio, modalidad de contrato, tiempo de servicio)

Tabla 2. Operacionalización de la variable

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de Medición	Criterio de Medición
Nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa	Percepción del personal de salud respecto a la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos administrativos en un hospital de Piura, durante el año 2025.	Condiciones físicas y materiales	Calidad en el trato y disponibilidad de recursos	1-5	Ordinal	Cuestionario
		Beneficios laborales remunerativos	Bonificaciones por trabajo adicional	6-10		
		Políticas administrativas	Participación en decisiones y representación democrática	11-15		
		Relaciones sociales	Condiciones laborales justas y libres de presión	16-20		
		Desarrollo personal	Clima laboral positivo y motivación	21-25		
		Desempeño de tareas	Eficiencia laboral y carga de trabajo equilibrada	26-30		
		Relación con la autoridad	Relaciones respetuosas y trato cordial	31-35		

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Criterios de medición
Características personales	Sexo	¿Cuál es su sexo?	Nominal	Masculino
				Femenino
	Edad	¿Cuál es su edad?	Ordinal	Menos de 30 años
				31 años - 40 años
				41 años - 50 años
				Más de 50 años
Características laborales	Servicio	¿En qué servicio labora?	Nominal	Emergencias
				Hospitalización
				UCI
				Diagnóstico por imágenes
				Laboratorio
	Modalidad de contrato	¿Cuál es su modalidad de contrato?	Nominal	Régimen decreto legislativo 276
				Régimen decreto legislativo 728
				CAS
				SNP

Tiempo de servicio	¿Cuánto tiempo de servicio tiene?	Ordinal	1 a 5 años
			6 a 10 años
			Más de 10 años

Tabla 3. Variables intervinientes

J. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Tipo de investigación

El estudio será de tipo descriptivo - comparativo con un enfoque cuantitativo. Se clasificará como descriptivo porque su objetivo principal será detallar el nivel de satisfacción del personal de salud con respecto a la gestión administrativa en un hospital de Piura-Perú, en el año 2025. A través de la recopilación de datos numéricos, el enfoque descriptivo permitirá caracterizar y cuantificar percepciones de los participantes en relación con las dimensiones de la gestión administrativa, como serán la planeación, organización, dirección y control. El estudio también será comparativo, ya que pretenderá analizar y contrastar los niveles de satisfacción del personal entre diferentes áreas de servicio: emergencias, hospitalización, UCI, diagnóstico por imágenes y laboratorio. Esto permitirá identificar similitudes o diferencias en sus percepciones sobre la gestión administrativa del hospital en sus respectivos servicios.

El enfoque de esta investigación será cuantitativo, ya que se utilizarán instrumentos estructurados, como cuestionarios con escalas tipo Likert, para recolectar datos numéricos sobre la satisfacción de los participantes. Este enfoque permitirá el uso de técnicas estadísticas para analizar los resultados, logrando una mayor objetividad y la posibilidad de generalizar los hallazgos a toda la población del hospital94.

- Diseño de investigación

El diseño de investigación será transversal no experimental. Será transversal porque la recolección de datos se realizará en un único momento del tiempo, específicamente en el año 2025, lo que proporcionará una "fotografía" instantánea del nivel de satisfacción de los participantes. Al ser un diseño no experimental no se manipularán las variables; es decir, no se intervendrá en las condiciones de la gestión administrativa, sino que se observará y medirá la satisfacción tal como se presentará en el contexto real del hospital. De esta manera, los datos se recopilarán sin influir en el entorno ni en los procesos administrativos, garantizando así la objetividad de los resultados. Este diseño será adecuado para describir fenómenos tal como ocurrirán y comparar los resultados entre los diferentes grupos de estudio95.

Se tendrán en cuenta variables intervinientes relacionadas con características personales y laborales del personal de salud. Entre las variables personales se consideran la edad y el sexo; mientras que entre las variables laborales se incluyen el servicio al que pertenece, la modalidad de contrato y el tiempo de servicio.

- Población y muestra

La población estará conformada por el conjunto total de elementos que poseen características definidas para la investigación y de donde se seleccionará la muestra a estudiar96; es decir, por el personal de salud del área asistencial que labore de manera presencial en el hospital.

La muestra será una porción representativa de la población seleccionada para la aplicación del instrumento de la recolección de datos, y se obtendrá mediante un muestreo probabilístico estratificado97, considerando como estratos a las siguientes áreas de servicio (emergencias, hospitalización, UCI, diagnóstico por imágenes y laboratorio). La distribución proporcional de la muestra se realizará de manera proporcional al número de trabajadores por estrato.
El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula para el cálculo de tamaño de muestral en poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. (Anexo 02)

- Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión: Trabajadores del área asistencial que laboren de manera presencial, que otorguen su consentimiento informado y que culminen con el llenado del instrumento de recojo de datos.
Criterios de exclusión: Trabajadores del área asistencial que no laboren de manera presencial, que no otorguen su consentimiento informado y que no culminen con el llenado del instrumento de recojo de datos.
Delimitación geográfica del estudio
Departamento de Piura
Piura, ubicado en el extremo noroeste de Perú, es un departamento que abarca 35 892,49 km², representando el 2,79% del territorio total del país. Está compuesto por 8 provincias y 64 distritos: Piura (9 distritos), Ayabaca (10 distritos), Huancabamba (8 distritos), Morropón (10 distritos), Paita (7 distritos), Sullana (8 distritos), Talara (6 distritos) y Sechura (6 distritos)98.
Debido a su cercanía con la línea ecuatorial, la costa de Piura goza de un clima cálido durante todo el año, con una temperatura promedio de 26 °C. Esta región costera exhibe características tanto de clima tropical en la zona yunga como de sabana tropical al nivel del mar, también conocido como clima seco tropical o bosque seco ecuatorial, similar al de una sabana tropical. Las temperaturas pueden oscilar entre los 40 °C como máxima y los 15 °C como mínima. Hacia el sur, en la zona costera colindante con el Departamento de Lambayeque, se presenta un clima semi desértico. Por otro lado, la sierra piurana presenta un clima húmedo subtropical y templado, con una temperatura promedio anual de 15 °C98.

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas
Para la recolección de datos se utilizará la encuesta, cuyo objetivo será recabar información sobre las opiniones, actitudes, percepciones o criterios de un grupo de individuos acerca de las diversas dimensiones del problema investigado99.

Instrumentos
Para medir la satisfacción del personal de salud en relación a la gestión administrativa se aplicará un cuestionario estructurado con 35 ítems, valorados en una escala de Likert de cinco puntos, donde: 1 corresponde "nada satisfecho", 2 a "poco satisfecho", 3 a "ni satisfecho ni insatisfecho", 4 a "satisfecho" y 5 a "muy satisfecho" (Anexo 01).
Los puntajes obtenidos se interpretarán en cinco niveles de satisfacción, de acuerdo con los siguientes rangos; muy bajo (1.00 – 1.80), bajo (1.81 – 2.60), moderado (2.61 – 3.40), alto (3.41 – 4.20) y muy alto (4.21 – 5.00).
La validez del instrumento se establecerá a través del juicio de expertos, con una V de Aiken de 0,91. La confiabilidad del instrumento se

evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, a partir de una prueba piloto. El análisis arrojó un valor de α = 0.96, lo que indica una consistencia interna excelente, evidenciando que el instrumento es confiable para su aplicación en la población estudio100 (Anexo 03).

- Toma de muestra

Acceso

Se obtendrá el acceso necesario al hospital a través de una solicitud formal al departamento de investigación y desarrollo de la institución. Se establecerá una colaboración estrecha con el personal responsable para facilitar la coordinación de entrevistas y la distribución del cuestionario entre los participantes.

Recolección de datos

La recolección de datos se llevará a cabo de manera sistemática y planificada. Se distribuirán los cuestionarios en formato físico y de manera presencial, además se garantizará la confidencialidad y el anonimato de las respuestas.

Análisis de datos

El análisis de los resultados obtenidos se llevará a cabo mediante estadística descriptiva, utilizando medidas de tendencia central, así como tablas y gráficos para visualizar los resultados con su promedio y desviación estándar.

Y se utilizará la prueba estadística de regresión lineal para explorar predictores de satisfacción. Se analizarán los datos con el software estadístico SPSS versión 27, trabajando con un nivel de significancia del 5% ($p<0,05$).

Procesamiento de muestras

Se establecerá un plan detallado para el procesamiento de muestras una vez que se hayan recolectado los datos a través de los cuestionarios. El procesamiento de muestras se llevará a cabo con rigurosidad y atención al detalle, asegurando la calidad y la integridad de los datos cuantitativos recopilados para el análisis posterior.

Aplicación de prueba piloto

Se llevó a cabo una prueba piloto a 17 trabajadores de salud del establecimiento de salud I-4 Santa Julia. La aplicación del instrumento permitió evaluar la fiabilidad del cuestionario (Anexo 04).

Análisis de resultados

El análisis de resultados en este proyecto de tesis se centrará en la interpretación y comprensión de los datos cuantitativos recopilados a través de cuestionarios, con el objetivo de explorar la relación entre el nivel de satisfacción del personal de salud con la gestión administrativa en un hospital de Piura – Perú 2025.

- Aspectos éticos de la investigación e integridad científica

La presente investigación se ejecutará respetando los principios éticos fundamentales que presiden la investigación científica en seres humanos. En ese sentido, se garantizará el cumplimiento de los principios de respeto por las personas, beneficencia, no maleficencia y justicia, establecidos en documentos internacionales como la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont.

El respeto por las personas se asegurará mediante la participación voluntaria de los trabajadores de salud, para ello, se solicitará la firma del consentimiento informado, garantizando que los participantes

puedan retirarse del estudio en cualquier momento sin que ello genere consecuencias para su situación laboral o personal.
Asimismo, se protegerá la privacidad y el anonimato de la información proporcionada por los participantes. Los datos recolectados serán utilizados exclusivamente con fines académicos y de investigación.
En cuanto al principio de beneficencia y no maleficencia, la investigación no implicará riesgos físicos ni psicológicos para los participantes, ya que únicamente se aplicará un cuestionario estructurado para recoger información sobre su nivel de satisfacción con la gestión administrativa.
Así también, se garantizará la integridad científica del investigador, comprometiéndose a realizar el estudio con responsabilidad y transparencia en todas las etapas del proceso de investigación, desde la recolección de datos hasta la presentación y difusión de los resultados.